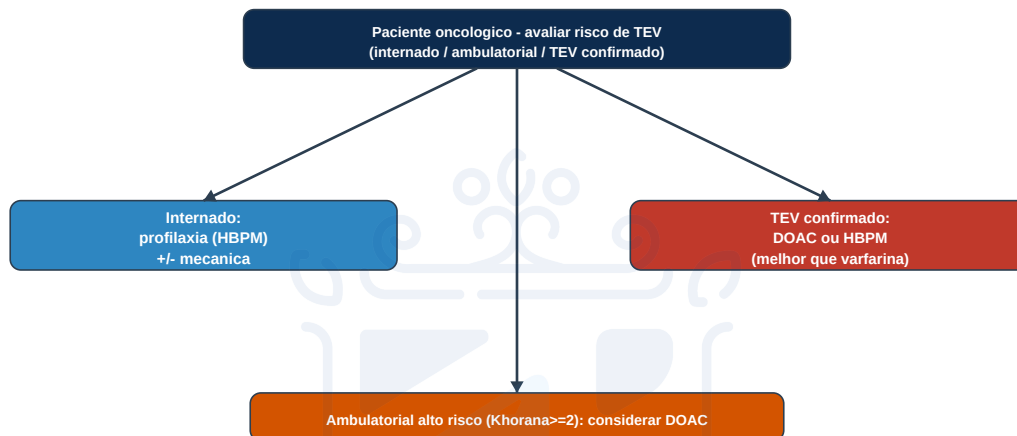


TEV NO CÂNCER — DOAC OU HBPM

FLUXOGRAMA — PROFILAXIA E TRATAMENTO

TEV NO CÂNCER — ANTICOAGULAR (NÃO VARFARINA)



CONTEXTO

POR QUE É DIFERENTE

- Câncer é estado de hipercoagulabilidade — alto risco de TVP/TEP
- Anticoagulantes de escolha no TEV do câncer: DOAC ou HBPM (ambos MELHORES que a varfarina, com menos sangramento)
- Varfarina NÃO é recomendada (mais sangramento, interações, controle difícil)
- Ressalva aos DOAC: neoplasia GASTROINTESTINAL (maior risco de sangramento) — preferir HBPM

PROFILAXIA PRIMÁRIA

Cenário	Conduta
Internado com neoplasia	Profilaxia para TEV (HBPM preferível à HNF)
Internado de ALTO risco	Profilaxia medicamentosa (HBPM) + mecânica (compressão pneumática)
Alto risco de SANGRAMENTO	Profilaxia MECÂNICA isolada
Pós-cirurgia abdominal/pélvica	Manter profilaxia (HBPM) por até 4 semanas após a alta
Ambulatorial em QT, alto risco (Khorana >= 2)	Considerar profilaxia com DOAC (apixabana ou rivaroxabana)

TRATAMENTO DO TEV CONFIRMADO

Rx ANTICOAGULAÇÃO

1a linha: DOAC (apixabana, rivaroxabana, edoxabana) OU HBPM — ambos superiores à varfarina
Neoplasia gastrointestinal / mucosite / sangramento: preferir HBPM (DOAC tem mais sangramento GI)
Trombocitopenia / função renal alterada: ajustar/escolher conforme o caso (HBPM com ajuste; cautela com DOAC se ClCr baixo)
Manter por $\geq$ 3-6 meses; enquanto houver câncer ATIVO/em tratamento, manter anticoagulação (tempo estendido)
Evitar varfarina (mais sangramento, interações com QT)

TEP INCIDENTAL / SUBSEGMENTAR

TRATAR MESMO SE ACHADO INCIDENTAL

- No câncer, TEP incidental deve ser SEMPRE tratado
- TEP subsegmentar: tratar se houver neoplasia ativa, múltiplos TEP, paciente hospitalizado ou TVP associada
- Achados incidentais em estadiamento são frequentes e clinicamente relevantes no câncer
- A decisão pondera sempre o risco de sangramento
- Escore de Khorana $\geq$ 2 = alto risco ambulatorial (limitação: subestima neoplasia renal e de SNC)

RED FLAGS / CUIDADOS

PONDERAR SANGRAMENTO

- Sempre avaliar o risco de SANGRAMENTO antes de anticoagular (plaquetopenia por QT, tumor sangrante, mucosite)
- TEP de alto risco (instabilidade) -> conduzir como TEP grave (reperusão), independentemente do câncer
- Varfarina desequilibra o risco/benefício (mais sangramento) — não recomendada
- Reavaliar periodicamente a indicação conforme atividade da doença e plaquetas
- Filtro de veia cava: reservar para contra-indicação absoluta à anticoagulação

MODELO DE REGULAÇÃO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente oncológico (___) com TEV ___ (TVP/TEP, incidental/subsegmentar?); estabilidade ___.
- Risco de sangramento: ___ (neoplasia GI? plaquetopenia?); função renal ___.
- Conduta: anticoagulação com ___ (DOAC/HBPM); profilaxia conforme cenário; tempo: enquanto câncer ativo.
- Solicito seguimento com oncologia; TEP de alto risco -> manejo de emergência (reperusão).

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com câncer e TVP confirmada. Qual o anticoagulante de escolha?

- A) Varfarina
- B) DOAC ou heparina de baixo peso molecular (ambos melhores que a varfarina)
- C) Apenas AAS
- D) Heparina não fracionada subcutânea de rotina
- E) Nenhum

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Em qual situação se prefere HBPM ao DOAC no tratamento do TEV do câncer?

- A) Neoplasia de pele
- B) Neoplasia gastrointestinal (maior risco de sangramento com DOAC)
- C) Câncer de mama em remissão
- D) Tumor cerebral pequeno
- E) Sempre o DOAC é preferível

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre o TEP incidental/subsegmentar no paciente oncológico, é correto:

- A) Nunca tratar
- B) TEP incidental deve ser sempre tratado; subsegmentar trata-se se neoplasia ativa, múltiplos TEP, hospitalizado ou TVP associada
- C) Tratar apenas se sintomático
- D) Tratar somente TEP central
- E) Observar por 30 dias

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual escore identifica pacientes ambulatoriais com câncer de alto risco para TEV (candidatos a profilaxia)?

- A) Escore de Wells
- B) Escore de Khorana (≥ 2)
- C) Escore de Genebra
- D) Escore de Caprini isolado
- E) Escore MASCC

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Por que a varfarina NÃO é recomendada no TEV associado ao câncer?

- A) Porque é cara
- B) Porque tem maior taxa de sangramento e interações, desequilibrando o risco/benefício frente a DOAC/HBPM
- C) Porque não é eficaz contra TVP
- D) Porque exige aplicação subcutânea
- E) Porque é contraindicada em qualquer trombose

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

No TEV do câncer, os anticoagulantes de escolha são os DOAC ou a HBPM, ambos com menos sangramento e melhor desfecho que a varfarina (que não é recomendada).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Prefere-se a HBPM ao DOAC quando há neoplasia gastrointestinal (e mucosite/lesões sangrantes), pelo maior risco de sangramento digestivo associado aos DOAC.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

No câncer, o TEP incidental deve ser sempre tratado; o subsegmentar trata-se se houver neoplasia ativa, múltiplos êmbolos, hospitalização ou TVP associada — ponderando o risco de sangramento.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O escore de Khorana (≥ 2 = alto risco) identifica pacientes ambulatoriais em quimioterapia candidatos a profilaxia primária com DOAC (apixabana/rivaroxabana). Subestima neoplasia renal e de SNC.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A varfarina tem maior taxa de sangramento, interações com a quimioterapia e controle difícil (INR instável), desequilibrando o risco/benefício frente aos DOAC e à HBPM.

SM24
Suporte ao Plantão Médico